

บทที่ 10

ความผิดปกติทางจิตและการบำบัด (Psychological Disorder and Therapy)

ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง

โครงร่างเนื้อหา

1. ความหมายของความผิดปกติทางจิต
2. สาเหตุของความผิดปกติทางจิต
3. ความผิดปกติทางจิตที่ควรรู้จัก
 - 3.1 โรคจิตเภท
 - 3.2 โรควิตกกังวล
 - 3.3 โรคย้ำคิดย้ำทำ
 - 3.4 โรคซึมเศร้า
 - 3.5 โรคอารมณ์สองขั้ว
 - 3.6 บุคลิกภาพที่ผิดปกติ
 - 3.7 ความผิดปกติทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ
 - 3.8 ความผิดปกติอันเนื่องมาจากภยันอันตรายและความเครียด
4. การบำบัดหรือการรักษา
5. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

สาระสำคัญ

1. ความหมายของความผิดปกติทางจิต คือ การมีความคิดและอารมณ์ที่ไม่เป็นสุขเป็นเวลานาน ที่ส่งผลให้การทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันบกพร่อง และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานทางสังคม รวมทั้งอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง

2. สาเหตุของความผิดปกติทางจิตที่ได้รับการยอมรับ คือ กรอบแนวคิดกาย-จิต-สังคม ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา

3. ความผิดปกติทางจิตที่ควรรู้จักมีอยู่ 8 กลุ่ม ได้แก่ โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว บุคลิกภาพที่ผิดปกติ ความผิดปกติทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ และความผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยอันตรายและความเครียด ซึ่งทุกกลุ่มมีอาการแสดง และสาเหตุการเกิดโรคที่แตกต่างกันไป

4. การบำบัดหรือการรักษา คือ กระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดปกติให้กลับสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การบำบัดมี 5 แนวทาง ได้แก่ วิธีการรักษาทางสมอง จิตพลวัตบำบัด พฤติกรรมบำบัด พฤติกรรมบำบัดผ่านการรู้คิด และการบำบัดตามแนวคิดมนุษยนิยมและเอกซิสเทนเชียล

5. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความหมาย และสาเหตุของความผิดปกติทางจิตได้
2. บอกถึงอาการ และแยกแยะความแตกต่างของความผิดปกติทางจิตแต่ละประเภทได้
3. อธิบายถึงหลักการ และแนวคิดสำคัญในการบำบัดรูปแบบต่าง ๆ ได้

ร่างทรงสติแตก-สั่งเชือดลูก

"แม่เพี้ยนหลังเข้าทรงกับพี่สาว-น้องสาว เชื่อว่าลูกสาววัย 12 ปีนำความชั่วร้ายมาให้ มอบหมายนำสาวแท้ๆ ของเหยื่อนำมีดอีโต้เชือดคอ ตับสยองจากนั้นทำพิธีส่งวิญญาณตัดเส้น ผสมของผู้ตายไปแช่น้ำ นำเสื้อผ้า-ที่นอนเผาทั้งสำรวจลากคอแม่อุบาทว์มาสอนให้การเหมือนคน เสียดสีว่าสื่อสารกับเทวดาได้"

(http://www.dmh.go.th/Sty_Lib/articles/view.asp?id=858)

พ่อพ่อโรคจิต ชังลูกสาว 10 ปี

"ผู้เป็นพ่อได้กักขังลูกสาวไว้ในบ้านตั้งแต่ อายุ 4-5 ขวบ โดยผู้เป็นพ่อเป็นคนที่ไม่สมประกอบ แต่เป็นคนรักลูกมาก ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาศัยญาติพี่น้องที่อยู่ในละแวกเดียวกันคอยดูแลเรื่องอาหารการกินและค่าใช้จ่ายสาเหตุที่ขังลูกไว้ในบ้านเพราะระแวงว่าจะมีคนมาทำร้ายลูกสาว"

(<http://highlight.kapook.com/view/24426>)

ตัวอย่างที่แสดงเป็นเพียงบางกรณีที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ หลายคนเรียกบุคคลในข่าวว่าเป็น "คนบ้า" "คนโรคจิต" "คนวิกลจริต" และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติเหล่านี้ นักจิตวิทยาเรียกว่าเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งมีสาเหตุของความผิดปกติทางจิตแตกต่างกัน จึงมีวิธีการบำบัดและให้ความช่วยเหลือบุคคลที่แตกต่างกันตามไปด้วย

1. ความหมายของความผิดปกติทางจิต

การให้ความหมายหรือนิยามคำว่า ความผิดปกติทางจิต (Psychological Disorder) เป็นสิ่งที่ซับซ้อน และมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแนวคิด รวมทั้งทฤษฎีที่นำมาใช้ ทั้งนี้มีผู้พยายามให้ความหมายของความผิดปกติทางจิตไว้มากมาย เช่น

คัมเมอร์ และกูลด์ (Comer and Gould, 2013, pp. 568-569) ให้คำจำกัดความของความผิดปกติโดยยึดหลัก The Four Ds ไว้ดังนี้

1. ความเบี่ยงเบน (Deviance) หมายถึง พฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ที่แตกต่างออกไปจากบรรทัดฐานที่สังคมกำหนด การตัดสินว่าสิ่งใดเบี่ยงเบนไปจากปกติมีความหลากหลายไปตามลักษณะของแต่ละสังคม เช่น สังคมที่มีค่านิยมแข่งขันและเหยียดชนชั้น อาจเป็นบุคคลที่มีความก้าวร้าวสูง ดังนั้นหากมีใครบางคนมีค่านิยมแบบมุ่งเน้นความร่วมมือ จะไม่

เป็นที่ยอมรับและถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนของสังคมนั้น นอกจากนี้ค่านิยมทางสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานำไปสู่มุมมองใหม่ ๆ ของสังคม เช่น บทบาทของสตรีที่แตกต่างจากอดีต เพราะสตรีในปัจจุบันมีส่วนร่วมในการแข่งกีฬา การเรียน ธุรกิจ หรือการเมืองมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงร้อยกว่าปีก่อน บทบาทของสตรีในปัจจุบันจึงถือเป็นความเบี่ยงเบนของคนยุคโบราณ

2. ความทุกข์ (Distress) นักทฤษฎีทางคลินิกกล่าวว่า พฤติกรรม ความคิด หรืออารมณ์ที่เป็นทุกข์ หรือไม่เป็นสุข เมื่อเกิดขึ้นเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ความผิดปกติทางจิต เช่น พนักงานบริษัทที่รู้สึกหมดไฟในการทำงาน มีความวุ่นวายใจตลอดเวลา เมื่อเกิดความคิดและความรู้สึกหมกมุ่นเช่นนั้นนานวันย่อมนำไปสู่ความผิดปกติทางจิตในที่สุด

3. การทำหน้าที่บกพร่อง (Dysfunction) อาการหรือพยาธิสภาพของโรคที่มีแนวโน้มรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตทุกข์ทรมาน และทวีความวิตกกังวลมากขึ้น จนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ไม่สามารถรักษาสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลรอบข้าง หรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่การทำหน้าที่บกพร่องเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงความผิดปกติทางจิตได้ ต้องอาศัยความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

4. ความเป็นอันตราย (Danger) ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตบางคนมีความเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองหรือต่อบุคคลรอบข้าง เช่น บุคคลที่มีความอาฆาตมาดร้าย อาจถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ไปยังสมาชิกในครอบครัว เพื่อน บุคคลที่ไม่เคยรู้จักกัน หรือในบางกรณีอาจเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้แล้วมาทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย

คูน และมิตเตอร์ (Coon and Mitterer, 2012, p.546) กล่าวว่า ความผิดปกติทางจิต หรือพยาธิสภาพทางจิต พิจารณาได้จากความล้มเหลวในการปรับตัว หรือกล่าวได้ว่าความล้มเหลวจากการปรับตัวเป็นผลสืบเนื่องจากความบกพร่องในกระบวนการทางชีวภาพ หรือทางจิตวิทยาทำให้บุคคลนั้นต้องเผชิญความยากลำบากในการตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ความล้มเหลวในการปรับตัวที่เป็นผลจากความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยา คือ ความยึดอัดใจ ไร้ความสามารถ หรือไม่สามารถควบคุมความคิด พฤติกรรม ความรู้สึกได้ เช่น พฤติกรรมเสี่ยงโชคไม่จัดเป็นปัญหา หากบุคคลนั้นเสี่ยงโชคเพื่อความบันเทิง และสามารถควบคุมตนเองได้ แต่ถ้าบุคคลนั้นติดการเสี่ยงโชคจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ย่อมเป็นสัญญาณของความผิดปกติทางจิต ตัวอย่างอีกประการหนึ่งคืออาการหูแว่ว ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบุคคลไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้ จัดว่ามีความผิดปกติ

ทางจิต อาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น ในกรณีนี้จัดว่ามีความผิดปกติทางจิตที่รุนแรง

เวด และเทวิส (Wade and Tavris, 2009, pp.370-371) ได้นิยามความหมายของความผิดปกติทางจิต ซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการ ดังนี้

1. พฤติกรรมที่จะเกิดต่อมาตรฐานทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคม หากผู้ใดประพฤติตนละเมิดต่อมาตรฐานทางวัฒนธรรมย่อมถูกมองว่าเป็นผู้มีความผิดปกติ

2. มีภาวะอารมณ์ที่ไม่เป็นสุข เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความหวาดกลัวที่ไม่เหมาะสม หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้สารหรือยาในการให้ความหมายของหลักการข้อนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ไม่สามารถทนได้ หรือพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของบุคคลหนึ่ง เช่น ความสนใจเรื่องเพศลดลง อาจเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือปกติสำหรับคนอื่น ๆ

3. มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง หรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายแก่ผู้อื่นมุ่งเน้นผลกระทบทางลบที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งบางพฤติกรรมอาจส่งผลร้ายต่อตนเอง เช่น กลัวอีกา จนไม่สามารถออกจากบ้านได้ ตื่นสุราจนไม่สามารถทำงานได้ นักเรียนที่วิตกกังวลจนไม่สามารถทำข้อสอบได้ ทั้งนี้รวมถึงบางกรณีที่ปฏิเสธว่าตนเองผิดปกติ แต่กระนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกย่อมแสดงถึงความผิดปกติ เป็นอันตราย หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่น ผู้ป่วยโรคจิตเภทมีอาการหูแว่ว

จึงสรุปได้ว่า บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต คือ บุคคลที่มีความทุกข์ทางใจ มีความคิดและอารมณ์ที่ไม่เป็นสุขเป็นเวลานาน ส่งผลให้การทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันบกพร่อง มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานทางสังคมหรือขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของสังคม โดยลักษณะดังกล่าวเป็นผลให้บุคคลมีความคิดและอารมณ์ผิดปกติ แสดงพฤติกรรมที่แปลกแยก และอาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1

ให้พิจารณาว่าข้อต่อไปนี้ เป็นความผิดปกติทางจิต “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”

1. นายพัฒน์ จุดไฟเผาแฟนตนเองเพราะแฟนนอกใจ
2. นายเอ รู้สึกตื่นกลัวทุกครั้งที่ต้องขึ้นลิฟท์หลังประสบเหตุลิฟท์ค้าง
3. นางพลับพลึงล้างคอให้อาเจียนหลังรับประทานอาหารเพราะกลัวอ้วน
4. นางสาวเจมไม่สามารถตัดสินใจว่าจะซื้อน้ำตาลยี่ห้อไหน หากไม่มีเพื่อนช่วยตัดสินใจ

2. สาเหตุของความผิดปกติทางจิต

โรคทางกาย ส่วนใหญ่สามารถวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาได้โดยการซักประวัติ ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายรังสี การตรวจเนื้อเยื่อ การตรวจเม็ดเลือด และอื่น ๆ แต่โรคทางจิตเวชหรือความผิดปกติทางจิตไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่กล่าวมาตรวจหาสาเหตุได้ ดังนั้นการทำความเข้าใจสาเหตุของความผิดปกติจึงเป็นสิ่งที่จิตแพทย์ แพทย์ทางประสาทวิทยา นักจิตวิทยา และนักทฤษฎีต่าง ๆ พยายามศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบ แต่สาเหตุของความผิดปกติทางจิตเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนและสัมพันธ์กับระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ จึงเกิดแนวคิดและทฤษฎีมากมายที่นำมาใช้อธิบายสาเหตุของความผิดปกติทางจิต กรอบแนวคิดที่นิยมนำมาใช้อธิบายสาเหตุของความผิดปกติทางจิต คือ กรอบแนวคิดกาย-จิต-สังคม (Bio-Psycho-Social framework) ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัยดังนี้

1. กาย หรือปัจจัยทางชีววิทยา มุ่งศึกษาสาเหตุของความผิดปกติทางจิตโดยพิจารณาปัจจัยทางร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็รูปรธรรมชาติและเป็นข้อมูลที่สามารถวัดได้ เช่น อายุ เพศ สุขภาพกายทั่วไป สารอาหาร อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต โรคเบาหวาน อาการปวดท้อง กล้ามเนื้อตึงเครียด กล้ามเนื้ออ่อนแรง ประวัติความเจ็บป่วยในวัยเด็ก ประวัติการผ่าตัด ภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว ภาวะฮอร์โมนแปรปรวน สารสื่อประสาท ความดันเลือดในสมอง โรคติดเชื้อ การขาดสารอาหาร ผลจากการใช้ยาหรือสารเสพติด การทำงานของสมองส่วนต่าง ๆ และพันธุกรรม เป็นต้น

2. จิต หรือ ปัจจัยทางจิตวิทยา มุ่งศึกษาสาเหตุของความผิดปกติทางจิตโดยพิจารณากระบวนการทำงานทางจิตใจด้านต่าง ๆ ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึกพฤติกรรม การตัดสินใจ การรู้คิด สมาธิ การรับรู้ ความจำ การเรียนรู้ สติปัญญา พัฒนาการทางความคิด ภาษา การจัดการกับปัญหา ปฏิกริยาต่อความเครียดและแรงกดดัน การใช้เหตุผล และความเชื่อ เป็นต้น

3. สังคม หรือ ปัจจัยทางสังคม มุ่งศึกษาสาเหตุของความผิดปกติทางจิตโดยพิจารณาบริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น ครอบครัว ชุมชน ศาสนา เป็นต้น



รูป 10-1 กรอบแนวคิดกาย-จิต-สังขม

กรอบแนวคิดกาย-จิต-สังขม เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและใช้กันในหมู่นักวิชาการด้านสุขภาพ จิตแพทย์ รวมถึงนักจิตวิทยา แนวคิดนี้เสมือนแผนผังความคิดที่ใช้ทำความเข้าใจบุคคลที่มีปัญหา อากาหรือความคิดที่ผิดปกติทางจิตอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตสามารถจัดระบบความคิดและข้อมูล รวมทั้งการวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตได้อย่างเหมาะสม (Zide & Gray, 2001, pp.8-9; Freeman, Felgoise and Davis, 2008, pp.156-166)

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2

ให้จำแนกสาเหตุของความผิดปกติทางจิตต่อไปนี้ว่าเป็นสาเหตุในกลุ่มใด

- | | | | |
|--|---------|---------|-----------|
| 1. นายอนันต์เป็นไข้ ชักบ่อย ๆ ช่วงวัยเด็ก |กาย |จิต |สังขม |
| 2. นางมนัสนันท์มีอาการซึมเศร้าหลังสามีเสียชีวิต |กาย |จิต |สังขม |
| 3. เพื่อนๆ ของเจนนี่ดื่มสุราทุกวัน ทำให้เจนนี่ต้องดื่มด้วย |กาย |จิต |สังขม |

3. ความผิดปกติทางจิตที่ควรรู้จัก

ความผิดปกติทางจิตวิทยาถูกจำแนกออกเป็นหลายกลุ่มตามลักษณะอาการและความรุนแรง ขึ้นอยู่กับที่มาของเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกตินั้น ๆ ในที่นี้ได้นำเสนอกลุ่มของความผิดปกติทางจิตที่ควรรู้จัก 8 กลุ่ม ไว้ดังนี้

3.1 โรคจิตเภท (Schizophrenia)

โรคจิตเภทเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง ที่เสมือนเป็นโรคมะเร็งของความเจ็บป่วยทางจิต เพราะเป็นโรคที่เข้าใจยาก ซับซ้อน และมีหลากหลายรูปแบบ คำว่า Schizophrenia หมายถึง สภาพจิตใจที่แตกแยก มีรากศัพท์จากภาษากรีก โดยที่มาของคำนี้เริ่มต้นใช้เมื่อปี ค.ศ. 1911 โดยจิตแพทย์ชาวสวิสนามว่า ออเกน บลอยเลอร์ (Eugen Bleuler) ได้ใช้คำนี้เพื่อสื่อความหมายถึง กระบวนการคิดที่แตกแยกซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดปกติ

บุคคลที่เป็นโรคจิตเภทจะปรากฏอาการเสื่อมถอยในการใช้ชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ เป็นระยะเวลานาน เช่น การทำงาน ความสัมพันธ์ทางสังคม และการดูแลตนเอง ร่วมกับมีอาการประสาทหลอน หลงผิด มีอาการสับสน และพูดไม่รู้เรื่อง มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ มีการตอบสนองทางอารมณ์และพฤติกรรมทางสังคมที่ผิดปกติ

อาการสำคัญของโรคจิตเภท

โรคจิตเภทประกอบไปด้วยอาการผิดปกติ ต่อไปนี้

1. การหลงผิด (Delusion) คือ เนื้อหาความคิดที่ผิดไปจากความจริง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยการให้เหตุผลตามปกติได้ เช่น ผู้ป่วยคิดว่าสุนัขที่พบเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ปลอมตัวเป็นสัตว์เลี้ยง หรือในรายที่มีความคิดหวาดระแวงเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ปกติ เช่น เห็นเฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือศีรษะจะคิดว่าตนเองถูกจับตามองหรือถูกปองร้ายอยู่

2. ประสาทหลอน (Hallucination) คือ การรับรู้ที่บิดเบือนไปจากความจริง โดยปราศจากสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้นซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกประสาทสัมผัสที่พบบ่อยคือประสาทหลอนทางการได้ยินหรือหูแว่ว เช่น ได้ยินเสียงคนอื่นสาปแช่ง หรือคำว้าคนเอง ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงไม่มีเสียงนั้น และประสาทหลอนทางการมองเห็น หรือภาพหลอน เช่น เห็นชายชุดดำถือปืนจะเข้ามาทำร้ายทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงไม่มีภาพนั้น

3. มีอาการสับสน และพูดจาไม่ต่อเนื่อง (Disorganized, Incoherent speech) ประกอบด้วยความคิดสับสนและไม่มีเหตุผล ซึ่งแสดงออกมาเป็นคำพูด คือ พูดคำที่ไม่มี ความหมาย ไม่ต่อเนื่อง ไม่เชื่อมโยง ทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจว่าผู้ป่วยต้องการอะไร

4. มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (Inappropriate behavior) เป็นการแสดงพฤติกรรมไร้เหตุผล ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่สามารถคาดเดาได้ และมีความรุนแรง เช่น การสวมเสื้อสามชิ้นและถุงมือในวันที่อากาศร้อน เก็บสะสมของใช้ที่ไม่มีประโยชน์จนเต็มพื้นที่ของห้องพัก

5. มีความบกพร่องทางการรู้คิด (Impaired cognitive abilities) ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษา การนึกถึงคำศัพท์และเรื่องราวต่าง ๆ การรับรู้ การจำ ความตั้งใจ และการจัดการกับปัญหา เป็นต้น ซึ่งอาการแสดงสำคัญอย่างหนึ่งคือการพูด

น้อยลง ตื้นลง หรือไม่ตอบสนองในขณะสนทนากับคู่สนทนา อันเป็นผลจากการลดลงของการทำงานของกระบวนการรู้คิด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ป่วย

อาการต่าง ๆ อาจปรากฏขึ้นไม่ก็ต่อเนื่อง ก่อนจะมีอาการหลงผิด หรือประสาทหลอน ซึ่งถือเป็นอาการรุนแรงของโรคนี้ เช่น ผู้ป่วยโรคจิตเภท อาจมีอาการเริ่มต้นจากการดูแลตนเอง และขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จากนั้นเริ่มขาดงาน ไม่อาบน้ำ และแยกตัว จนกระทั่งมีอาการมึนงงเฉื่อย ไม่แสดงสีหน้า ไม่สบตา ไม่ตอบสนอง อยู่ในโลกส่วนตัวโดยนั่งอยู่คนเดียวเป็นชั่วโมงโดยไม่มีการเคลื่อนไหว

สัญญาณของโรคจิตเภทในผู้ป่วยบางรายพบว่าเริ่มส่อเค้าตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นหรือในบางรายอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน บางรายอาจเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปที่ละเล็กละน้อย และเมื่อได้รับการรักษาแล้ว โดยส่วนมากมักกลับมาเป็นซ้ำได้ โอกาสที่จะหายขาดหรือไม่กลับมาป่วยซ้ำเป็นไปได้น้อย ผู้ป่วยโรคจิตเภทส่วนใหญ่ต้องทนทุกข์กับอาการของตนเอง จำเป็นต้องได้รับยาต้านอาการของโรคจิต ร่วมกับความช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชน จะช่วยให้มีอาการดีขึ้น (Kalat, 2017, pp.508-509; Wade and Tavris, 2009, pp.394-396; Weiten, 2007, pp.573-574)

3.2 โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder)

แม้ที่รอฟังข่าวผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตก หรือทหารเกณฑ์ที่กำลังรอคิวกระโดดร่มชูชีพ หรือบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ ควบคุมอะไรไม่ได้ เหล่านี้เป็นความวิตกกังวลที่ปกติ กล่าวคือเป็นความวิตกกังวลที่เหมาะสมต่อสถานการณ์หรือสิ่งเร้า ซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้ทำให้บุคคลมีการเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เป็นอันตราย แต่ผู้ที่มีความหวาดกลัวหรือวิตกกังวลที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญ และเมื่อเหตุการณ์ที่ทำให้วิตกกังวลผ่านไปแล้ว แต่ความวิตกกังวลยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องเหล่านี้เป็นอาการของโรควิตกกังวล ซึ่งตัวอย่างความผิดปกติในกลุ่มนี้ มีดังนี้

1. โรควิตกกังวล (Generalized Anxiety Disorder) อาการสำคัญของโรคคือมีความวิตกกังวลอย่างมากและต่อเนื่อง จนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งเกิดขึ้นหลายวันไปจนถึง 6 เดือน ลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางกาย เช่น โรคทางกาย การใช้ยา การดื่มกาแฟมากเกินไป ผู้ที่เป็นโรควิตกกังวลอาจมีอาการแสดงดังนี้ กระสับกระส่าย กระวนกระวาย ว้าวุ่น ใจ เกรียด มีความยากลำบากในการใช้สมาธิ ไม่พอใจ ไม่สามารถสลัดความกังวลออกจากใจได้ และมีปัญหาการนอน เป็นต้น

ผู้ป่วยโรควิตกกังวลต้องทนทุกข์ทรมานต่ออาการของโรค แม้ว่าจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่สร้างความวิตกกังวลโดยตรง และบ่อยครั้งพบว่าผู้ป่วยโรควิตกกังวลมีอาการทางกายร่วมด้วย เช่น เหนื่อยล้ามือ ใจเต้นรัว หายใจสั้น เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่สามารถควบคุมได้ อาการเช่นนี้ส่งผลต่อการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย เช่น การเรียน และการทำงาน เพราะผู้ป่วยจะต้องกังวลต่อสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นโรควิตกกังวลหลายคนมีประวัติว่าเริ่มเป็นตั้งแต่วัยเด็ก สาเหตุเกิดจากการเลี้ยงดูเด็กด้วยความกังวล และปลูกฝังให้เด็กมีความวิตกกังวลต่อสิ่งรอบข้างมาตั้งแต่เล็ก ๆ ลักษณะเช่นนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นอันตราย และเป็นจุดเริ่มต้นของโรควิตกกังวล

2. โรคตื่นตระหนก (Panic Disorder) จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของความวิตกกังวลที่ผิดปกติ ผู้ป่วยโรคนี้จะเกิดความหวาดกลัวตื่นตระหนกในระดับรุนแรง เกิดขึ้นบ่อย ๆ โดยไม่มีสิ่งใดมากระตุ้น และมีความวิตกกังวลว่าอาการเหล่านั้นจะเป็นซ้ำขึ้นมาอีก หรือกลัวผลที่จะเกิดตามมาจากการมีอาการหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป จนมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก ทั้งนี้ความตื่นตระหนกอาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาที และพบได้น้อยที่จะเกิดขึ้นยาวนานหลายชั่วโมง เมื่อตื่นตระหนกจะมีอาการ เช่น ตัวสั่น วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม สับสน เจ็บหน้าอก หายใจหอบ หัวใจเต้นรัว รู้สึกพว้างเลื่อน สะบัดร้อนสะบัดหนาว เหงื่อออก เป็นต้น ทั้งหมดเป็นผลจากปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายต่อความกลัวตาย ทำให้สูญเสียการควบคุม ผู้ป่วยโรคนี้จำนวนมากเสี่ยงต่อโรคหัวใจวาย

แม้ว่าโรคตื่นตระหนกจะเกิดขึ้นได้ไม่จำกัดสถานที่และเวลา แต่ที่พบบ่อยจะเกิดหลังจากเผชิญความเครียด การประสบเหตุคุกคาม ความกังวลที่เฉพาะเจาะจง และการอยู่ในอารมณ์ที่ต่อเนื่องยาวนาน เช่น บุคคลกำลังโดยสารเครื่องบินที่เป็นเป้าหมายการวางระเบิด ขณะที่บินอยู่บนความสูง 33,000 ฟุต แม้ว่าขณะนั้นจะปรับตัวและผ่านพ้นไปได้ แต่หลังจากนั้น 2 สัปดาห์เริ่มมีอาการตื่นตระหนก ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างบุคคล การตอบสนองของร่างกาย และอิทธิพลทางวัฒนธรรมล้วนมีผลต่อการพัฒนาโรคตื่นตระหนก นอกจากนี้การเกิดความตื่นตระหนกหลังเหตุการณ์ที่คุกคามชีวิตผ่านไปถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้

3. โรคกลัว (Phobia Disorder) ความกลัวเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างมีเป้าหมายต่ออันตรายภายนอก เช่น การหนี หรือต่อสู้ เพื่อป้องกันตนเองถือเป็นธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ ในทางตรงข้ามบุคคลที่เป็นโรคกลัวจะมีความกลัวที่มากกว่าปกติต่อสถานการณ์ หรือวัตถุ หรือกิจกรรมเฉพาะบางอย่างซึ่งเป็นความหวาดกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลต่อสิ่งเหล่านั้น ๆ และเกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างเป็นแบบแผน

สิ่งเร้าที่ทำให้เกิดโรคกลัวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เช่น โรคกลัวความสูง (Acrophobia) โรคกลัวที่แคบ (Claustrophobia) โรคกลัวความสกปรก (Autmysophobia) หรือโรคกลัวเชื้อโรค (Germophobia) ทั้งนี้ สาเหตุอาจเป็นจากผลการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก หรือการอยู่ในสถานการณ์เสียขวัญขณะที่ปรากฏสิ่งเร้านั้นอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ย่อมส่งผลให้บุคคลเชื่อมโยงความกลัวเข้ากับสิ่งเร้านั้น นอกจากนี้โรคกลัวบางประเภท เช่น โรคกลัวหมายเลข 13 (Triskaidekaphobia) เป็นโรคกลัวที่สะท้อนความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละสังคม

ไม่ว่าแหล่งที่มาของความกลัวคืออะไรแต่โรคกลัวไม่ได้ทำให้บุคคลนั้น ๆ แสดงออกเพียงแค่รังคังใจหรือกระโดดหนีจากสิ่งเร้าที่เป็นต้นเหตุเท่านั้น บุคคลที่เป็นโรคกลัวจะเสียขวัญ หวาดกลัว เป็นทุกข์ มีการปรับตัวไม่เหมาะสม มีอาการทางกายของระบบประสาท ซึมพาเทติก และไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเร้าที่เป็นสาเหตุ เช่น หากบุคคลเป็นโรคกลัวหมายเลข 13 เมื่อถึงวันศุกร์ที่ 13 บุคคลดังกล่าวจะมีความระมัดระวังอันตรายตลอดวัน และหากไม่เกิดอันตรายบุคคลนั้นจะเชื่อว่าความพยายามของตนเป็นผลสำเร็จ แต่หากโชคร้ายเกิดอันตรายบางอย่าง บุคคลนั้นจะตอกย้ำความเชื่อว่าวันศุกร์ที่ 13 เป็นวันที่อันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิต จนเกิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 13 อย่างต่อเนื่อง เป็นผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

4. โรควิตกกังวลทางสังคม (Social Anxiety Disorder) บุคคลที่เป็นโรคนี้จะเผชิญกับความวิตกกังวลอย่างยิ่งเมื่อต้องมีส่วนร่วมในที่สาธารณะ หรือสถานการณ์ที่ตนเองต้องตกเป็นเป้าสายตาของผู้อื่น มีความวิตกกังวลที่มากกว่าปกติและไม่สมเหตุสมผล จึงพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านั้น ผลที่ตามมาอาจทำให้ความสามารถในการทำหน้าที่หรือการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นบกพร่อง (รัตน สายพานิชย์ และธนิศา หิรัญเทพ, 2558 ;Kalat, 2017, pp.490-491; Wade and Tavis, 2009, pp.376-380; Gerrig and Zimbardo, 2008, pp.459-463)

3.3 โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder)

โรคย้ำคิดย้ำทำ คือ ลักษณะของความคิดและพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นเป็นแบบแผนซ้ำไปซ้ำมา โดยที่ผู้ป่วยไม่ปรารถนา รวมถึงพฤติกรรมที่เสมือนเป็นพิธีกรรมที่ต้องปฏิบัติซ้ำ ๆ เพื่อสนองต่อความรู้สึกหลีกเลี่ยงอันตรายของผู้ป่วย คนปกติทั่วไปอาจมีพฤติกรรมย้ำทำในเรื่องที่ไม่เป็นสาระได้ แต่สำหรับผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำจะมีความทุกข์ทรมานจากความคิดและพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน

จากการศึกษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำจำนวนมาก พบว่าสมองส่วนหน้าผลิตสารสื่อประสาทซีโรโทนินน้อยผิดปกติ ซึ่งเป็นผลให้กระบวนการรู้คิดไม่มีความยืดหยุ่น และขาดความสามารถในการคิดวางแผน นอกจากนี้ยังพบว่าบางส่วนของสมองมีการทำงานที่มากเกินไป สำหรับคนปกติเมื่อผ่านพ้นอันตรายไปแล้วสมองจะปิดสัญญาณเตือนภัย แต่สำหรับผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำพบว่าสัญญาณเตือนภัยที่ปล่อยออกมา มีความผิดพลาด ทำให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมรับอันตรายตลอดเวลาเพื่อลดความวิตกกังวล

ผู้ป่วยย้ำคิดย้ำทำประเภทหนึ่งจะมีพฤติกรรมเก็บสะสมสิ่งของ (Hoarding Disorder) เช่น หนังสือพิมพ์ กล่องทิชชูที่ใช้แล้ว และสิ่งของประเภทขยะ ผู้ป่วยจะเป็นทุกข์และกลัวที่ต้องทิ้งบางอย่างไป จากการถ่ายภาพสมอง (PET-scan) พบว่าผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำที่เก็บสะสมสิ่งของมีสมองบางส่วนที่ทำงานน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความเข้าใจมิติสัมพันธ์ และความจำ ซึ่งความบกพร่องเหล่านี้ช่วยอธิบายที่มาของพฤติกรรมเก็บสะสมสิ่งของที่ไร้ค่าไว้ในห้องรับแขก ห้องครัว หรือแม้แต่ห้องนอนของผู้ป่วยได้ (Wade and Tavis, 2009, pp.376-380; Gerrig and Zimbardo, 2008, pp.459-463)

3.4 โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder)

โรคซึมเศร้าเปรียบเสมือนโรคไข้หวัดของความผิดปกติทางจิตเพราะโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นบ่อย และทุกคนมีประสบการณ์ซึมเศร้าในบางช่วงของชีวิต สำหรับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าจะพิจารณาจากความรุนแรง และระยะเวลาที่แสดงอาการ ซึ่งปรากฏขึ้นอย่างรุนแรงและเป็นระยะเวลานานหลายสัปดาห์จึงถือว่ามีความผิดปกติ

โรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ระดับรุนแรงที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรม การรู้คิด และร่างกาย ซึ่งรบกวนการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง คิดถึงเรื่องความตาย และการฆ่าตัวตาย ไม่สนใจ และรู้สึกไม่พึงพอใจต่อกิจกรรมต่าง ๆ ไม่อยากตื่นนอน ไม่อยากทำกิจวัตร ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำอะไรบางอย่าง เช่น การแต่งตัวยามเช้า นอกจากนี้ยังรู้สึกล้มเหลว รับรู้ความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นเรื่องรุนแรง ไม่สามารถรู้สึกชื่นชมหรือพอใจกับเหตุการณ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้นได้เหมือนคนปกติ ไม่สามารถระลึกถึงความสุขหรือสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุข ในขณะที่บุคคลปกติเมื่อมีความเศร้าเสียใจ จะไม่มองตนเองไร้ค่าหรือเป็นคนที่ไม่ใคร่รัก แต่ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมองตนเองเป็นผู้ล้มเหลว ไร้มีค่า และไม่สามารถมีความสุขได้อีก

โรคซึมเศร้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายลักษณะ เช่น มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มากกว่าปกติ หรืออาจรับประทานอาหารน้อยลง นอนไม่หลับ หรือนอนหลับ ๆ

คืน ๆ มีปัญหาการใช้สมาธิ และรู้สึกเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลา นอกจากนี้อาจพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดหัว และความเจ็บปวดที่อธิบายสาเหตุที่มาไม่ได้

จากการเก็บข้อมูลทั่วโลกพบว่าโรคซึมเศร้าจะเกิดในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายถึงสองเท่า ทั้งนี้ สืบเนื่องจากผู้หญิงจะพูดหรือเล่าถึงความรู้สึกของตนเองมากกว่าผู้ชาย จึงแสวงหาความช่วยเหลือมากกว่าผู้ชาย เป็นผลให้ผู้ชายได้รับการวินิจฉัยโรคนี้น้อยกว่า ในขณะที่ผู้หญิงที่เป็นโรคซึมเศร้าพยายามปิดบังความรู้สึกนั้นโดยการแยกตัว การดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด หรือใช้ความรุนแรง เป็นต้น (Kalat, 2017, pp.503-504; Wade and Tavris, 2009, pp.380-384; Gerrig and Zimbardo, 2008, pp.464-469; Weiten, 2007, pp.569-572)

3.5 โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder)

โรคอารมณ์สองขั้ว เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งมีการแสดงอารมณ์สองขั้ว ได้แก่ ขั้วของอารมณ์ซึมเศร้า สลับกับขั้วของอารมณ์คลุ้มคลั่งหรือมีอารมณ์ครื้นเครงเกินปกติ ผู้ป่วยในช่วงอารมณ์คลุ้มคลั่งจะมีอารมณ์ร่าเริงสุดขีด รู้สึกเต็มเปี่ยมด้วยพลัง ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย มีแผนการต่าง ๆ มากมาย มักพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบายอย่างสุรุ่ยสุร่าย เช่น เล่นพนัน ซื้อของขวัญราคาแพงให้คนแปลกหน้า หุนหันพลันแล่น การตัดสินใจไม่ดี และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ต่อมาเมื่อผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วเข้าสู่ช่วงอารมณ์ซึมเศร้าจะรู้สึกผิดและมีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โรคอารมณ์สองขั้วพบได้ยากกว่าโรคซึมเศร้าโดยเกิดขึ้นร้อยละ 3.9 ของวัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่าโรคอารมณ์สองขั้วเกิดในผู้หญิงและผู้ชายในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนระยะเวลาและความถี่ของความแปรปรวนทางอารมณ์มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนมีช่วงเวลาที่เป็นปกติยาวนาน แต่มีจังหวะของอารมณ์ซึมเศร้า และอารมณ์คลุ้มคลั่งสั้น ๆ อาการของโรคจะเกิดขึ้นสลับกันไปมาเป็นวงจรระหว่างช่วงอารมณ์ซึมเศร้า กับช่วงอารมณ์คลุ้มคลั่งโดยไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมาน ทำลายชีวิต ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัวและการทำงาน

การทำความเข้าใจสาเหตุของโรคอารมณ์ผิดปกติจำเป็นต้องบูรณาการปัจจัยทางชีวภาพร่วมกับปัจจัยทางจิตวิทยา จึงจะเห็นภาพสมบูรณ์เกี่ยวกับโรคนี้ จากการศึกษาวิจัยทำให้ทราบว่าปัจจัยทางพันธุกรรม และชีวเคมีในสมอง (สารสื่อประสาทซีโรโทนิน และนอร์อิพิเนฟริน) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคความผิดปกติทางอารมณ์ ในขณะเดียวกันนักทฤษฎีทางการรู้คิดได้ศึกษาพบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างความคิดทางลบกับโรคซึมเศร้า รวมทั้งกลุ่มนักทฤษฎีทางพฤติกรรมพบว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคลหรือชาติทักษะทางสังคม มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดกับโรคอารมณ์ผิดปกติด้วย (Wade and Tavis, 2009, pp.380-384; Gerrig and Zimbardo, 2008, pp.464-469; Weiten, 2007, pp.569-572)

3.6 โรคบุคลิกภาพที่ผิดปกติ (Personality Disorder)

โรคบุคลิกภาพที่ผิดปกติหรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน หมายถึง ลักษณะนิสัยและรูปแบบการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม เปลี่ยนแปลงได้ยาก ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจ และทำให้ไม่สามารถสร้างความผูกพันกับผู้อื่นได้ ในเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ฉบับที่ 5 (DSM-5) ได้อธิบายว่า เป็นรูปแบบพฤติกรรมและประสบการณ์ภายในที่เป็นแบบแผนซึ่งเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้การวินิจฉัยแยกบุคลิกภาพที่ผิดปกติต้องไม่ใช่ผลจากอาการเจ็บป่วยทางกาย ความเครียด หรือสถานการณ์ชักนำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ ซึ่งโรคบุคลิกภาพผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัยของพัฒนาการตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ วัยชรา โดยมากจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น เพราะความผิดปกติพัฒนาขึ้นจากรากฐานของการเกิดบุคลิกภาพและใช้เวลาหลายปี นอกจากนี้บุคลิกภาพที่ผิดปกติมีหลายชนิดและมีระดับความบกพร่องที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง 10.1 (Coon and Mitterer, 2016, p477-478; Coon and Mitterer, 2012, pp.576-578; Wade and Tavis, 2009, pp.384-387; Gerrig and Zimbardo, 2008, p.470)

ตาราง 10-1

แสดงชนิด ระดับความบกพร่อง และลักษณะอาการของโรคบุคลิกภาพผิดปกติ

ชนิด (ร้อยละชาย/หญิง)	ระดับความ บกพร่อง	ลักษณะอาการ
บุคลิกภาพผิดปกติแบบ พึ่งพิง (Dependent Personality Disorder) (31/69)	ปานกลาง	ขาดความเชื่อมั่น สมยอม และยอมจำนน ต่อผู้อื่น ยึดติด และพึ่งพาผู้อื่น ต้องการให้ ผู้อื่นเข้ามาตัดสินใจชีวิตส่วนตัว
บุคลิกภาพผิดปกติแบบหลง ตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder) (70/30)	ปานกลาง	รู้สึกว่าคุณค่าดีเยี่ยม เป็นอัจฉริยะ มี ความสำคัญ มีคุณค่า ชื่นชมตนเอง ตลอดเวลา และไม่มีความรู้สึกร่วมกับผู้อื่น

ชนิด (ร้อยละชาย/หญิง)	ระดับความ บกพร่อง	ลักษณะอาการ
บุคลิกภาพผิดปกติแบบ ต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) (82/18)	ปานกลาง	ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น ขาดความ รับผิดชอบ ไม่รู้สึกผิด ขาดสำนึกต่อการ กระทำ แสดงพฤติกรรมต่อต้าน ก้าวร้าวไม่ ซื่อสัตย์ หลอกลวง ฉ้อโกง และไม่ยั้งคิด
บุคลิกภาพผิดปกติแบบ แยกตัว (Schizoid Personality Disorder) (78/22)	รุนแรง	ขาดความพึงพอใจในการสร้าง ความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่สามารถผูกพัน ใกล้ชิดกับผู้อื่น และไม่มีอารมณ์ร่วมใน สถานการณ์ทางสังคม
บุคลิกภาพผิดปกติแบบถอย หนี (Avoidant Personality Disorder) (50/50)	รุนแรง	เขินอาย รู้สึกไม่มั่นคง ไม่สบายใจเมื่ออยู่ใน สถานการณ์ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จึงแสดงออกแบบหลีกเลี่ยง และประเมิน สถานการณ์ทางสังคมบนพื้นฐานของ ความรู้สึกกลัว (กลัวถูกปฏิเสธ และกลัวถูก วิจารณ์)

3.7 ความผิดปกติทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ (Somatic Symptom and Related Disorders)

ความผิดปกติทางกายที่มีสาเหตุจากจิตใจ เป็นกลุ่มอาการของความผิดปกติทางจิตซึ่งแสดงออกในลักษณะของอาการทางร่างกาย หรือกล่าวคือสาเหตุของความผิดปกติทางกายนั้นเป็นผลมาจากสภาพจิตใจมากกว่าเป็นผลจากทางร่างกาย บุคคลที่ป่วยด้วยโรคนี้จะทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือบ่นถึงความเจ็บป่วยทางกายโดยไม่สามารถอธิบายที่มาของความเจ็บปวดตึงกล้ามเนื้อด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเป็นอาการที่ไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งของผู้ป่วย ตัวอย่างของความผิดปกติในกลุ่มนี้ ได้แก่

1. โรคความผิดปกติเกี่ยวกับอาการทางกาย (Somatic Symptom Disorder)

บุคคลที่ป่วยด้วยโรคนี้มีอาการสำคัญ คือ การแปลความหมายอาการทางกายผิดไปจากความจริง แสดงออกถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการทางกายมาก ใช้ความพยายามค้นหาสาเหตุของความผิดปกติมาก แม้ว่าจะไม่สามารถหาที่มาของความผิดปกตินั้นได้

2. โรควิตกกังวลต่อความเจ็บป่วย (Illness Anxiety Disorder) ผู้ป่วยโรคนี้เชื่อว่าตนเองมีความเจ็บป่วยทางกายรุนแรง แม้ว่าจะไปรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วไม่พบความผิดปกติทางกายที่รุนแรงก็ตาม หรือแม้แต่ในยามที่ไม่เจ็บป่วยใด ๆ ผู้ป่วยโรคนี้จะกังวลต่อการเจ็บป่วยที่ยังไม่เกิดขึ้น และหมกมุ่นสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจ และเกิดความบกพร่องในการใช้ชีวิตประจำวัน

3. โรคคอนเวอร์ชัน (Conversion Disorder) หรือโรค "ฮิสทีเรีย" (Hysteria) ลักษณะอาการสำคัญคือสูญเสียการควบคุมอวัยวะเกี่ยวกับตา เคลื่อนไหว หรือระบบรับสัมผัส ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของระบบประสาท หรือระบบอื่น ๆ ทางกายภาพ เช่น มีอาการวิงเวียนเป็นลมโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แต่เกิดจากปัญหาทางจิตใจ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือความเครียด ในบางยุคสมัยเชื่อว่ามีสาเหตุจากการถูกปิตาจารย์เข้าสิงแต่แนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากคือแนวคิดที่เชื่อว่าโรคนี้เป็นผลจากผู้ป่วยเคยมีบาดแผลทางจิตใจ

นักวิจัยพยายามศึกษาหาสาเหตุของความผิดปกติทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ โดยวิธีศึกษาจากกระบวนการรู้คิดของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยจะมีการรายงานอาการที่เกินความจริง มีความเครียดและกังวลสูงมากนำไปสู่การเจ็บป่วยและเป็นโรคจริง ๆ เช่น โรคความดันโลหิต อุดราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ (Coon and Mitterer, 2016, p474-475; Gerrig and Zimbardo, 2008, p.472-473)

3.8 ความผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยอันตรายและความเครียด (Trauma and Stressor Related Disorder)

เมื่อมนุษย์เผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความกังวล หรือความกลัว มนุษย์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวโดยละทิ้งความทุกข์เหล่านั้นไว้เบื้องหลัง และหลีกเลี่ยงการเผชิญกับความทุกข์ในอนาคต สิ่งนี้ถือเป็นสัญชาตญาณเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์ แต่สำหรับความผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยอันตรายและความเครียด จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับภัยอันตราย หรือความเครียดที่เกินกว่าความสามารถในการปรับตัว ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานติดอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตของตนเอง ตัวอย่างของความผิดปกติในกลุ่ม คือ

โรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง (Posttraumatic Stress Disorder; PTSD) อาการที่เกิดจากความเครียดเมื่อเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น นอนไม่หลับ กระวนกระวาย สะดุ้งตื่น ซึ่งอาการที่กล่าวมานี้เป็นอาการปกติสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตหรือบาดแผลทางใจ เช่น สงคราม การถูกข่มขืน การถูกทรมาน ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การสูญเสีย

บุคคลที่รักแบบกะทันหัน หรือการเผชิญภัยก่อการร้าย หากอาการดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องมากกว่า 1 เดือน และทำให้กิจวัตรการทำหน้าที่ของบุคคลนั้นสูญเสียไป จึงกล่าวได้ว่าบุคคลนั้น ๆ เป็นผู้ป่วยโรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง โดยอาการสำคัญของผู้ป่วยโรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง ได้แก่ การระลึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นซ้ำไปมาโดยไม่สามารถควบคุมความคิดได้ สูญเสียความสนใจในกิจกรรมรอบข้าง นอนไม่หลับ ฝันร้าย ละเมอกรีดร้อง หงุดหงิด และไม่มีสมาธิ

ผู้คนส่วนใหญ่ที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงจะสามารถฟื้นกลับมาเป็นปกติได้ มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาสภาพปกติเช่นเดิม ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาการปรับอารมณ์ นอกจากนี้ บุคคลเป็นโรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางสังคม ย่อมมีความยากลำบากที่จะจัดการปัญหา รวมทั้งบุคคลที่มีระดับสติปัญญาดำกว่าเฉลี่ยย่อมขาดความสามารถทางการรู้คิดที่จะจัดการกับปัญหาที่เผชิญ

จากการศึกษาขนาดของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสพบว่าผู้ป่วยโรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงมีขนาดสมองส่วนดังกล่าวเล็กกว่าปกติ ซึ่งสมองส่วนฮิปโปแคมปัสเป็นสมองที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการจำเหตุการณ์ในชีวิตของตน (autobiographical memory) ลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงมีความยากลำบากในการตอบสนองกับความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายแรงนั้น จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยยังคงระลึกเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำเรื่อยมา (Coon and Mitterer, 2016, p.473-474; Wade and Tavis, 2009, pp.376-380; Gerrig and Zimbardo, 2008, pp.459-463)

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3

ให้จับคู่อาการทางจิตเวชต่อไปนี้ว่าเข้าได้กับโรคทางจิตเวชใด

ก. โรคคอนเวชั่น ข. โรคจิตเภท ค. โรคอารมณ์สองขั้ว

ง. โรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง จ. โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม

-1. นายเดชหกล้มไม่ได้สติ หลังจากจับใบแดงได้เป็นทหารเกณฑ์
-2. นางรักษ์เชื่อว่าตนเองเป็นเจ้าแม่กวนอิมกลับชาติมาเกิด
-3. นายธนาซื้อสร้อยทองเป็นของขวัญให้แม่ค้าขายข้าวแกงที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก
-4. นายคำชอบแข่งรถชิงบนถนนสาธารณะ และทะเลาะวิวาทเพราะถูกมองหน้า
-5. เด็กชายพลร้องไห้ทุกครั้งที่ได้ผ่านทะเลหลังเผชิญเหตุการณ์สึนามิ

4. การบำบัดหรือการรักษา (Therapy or Treatment)

การบำบัดหรือการรักษา คือ กระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดปกติให้กลับสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เจโรม แฟรงค์ (Frank as cited in Comer and Gould, 2013 pp.615-616) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ทำให้เกิดการบำบัดว่ามี 3 องค์ประกอบ คือ (1) ผู้ป่วยแสวงหาหนทางบรรเทาอาการของตนจากผู้บำบัด (2) ผู้บำบัดได้รับการฝึกฝนและได้รับการยอมรับจากสังคม (3) การพบกันอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้บำบัดและผู้ป่วย เมื่อสามองค์ประกอบเกิดขึ้นพร้อมกันกระบวนการบำบัดจึงเริ่มขึ้น บางครั้งการบำบัดอาจดำเนินการในรูปแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ อารมณ์ และพฤติกรรม การบำบัดทางจิตมีรูปแบบและแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น 5 แนวคิดหลัก ดังนี้

4.1 วิธีรักษาทางสมอง (Brain approaches) เกิดจากการศึกษาของนักประสาทวิทยาที่มีมุมมองต่อพฤติกรรมที่ผิดปกติว่าเกิดจากการทำหน้าที่บกพร่องของสมอง เนื่องจากนักวิจัยค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างความผิดปกติทางจิตวิทยากับความผิดปกติทางประสาทวิทยา ดังนั้นความเป็นไปได้ของความเจ็บป่วยทางจิตตามแนวคิดกลุ่มนี้จึงเกี่ยวกับความผิดปกติของโครงสร้างสมอง การทำหน้าที่ผิดปกติของระบบสารสื่อประสาท หรือการติดเชื้อไวรัสในสมอง ส่งผลให้วิธีการบำบัดตามฐานแนวคิดนี้เป็นวิธีทางการแพทย์ การใช้เคมี และวิธีทางกายภาพ ดังนั้นนักบำบัดในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นจิตแพทย์ที่ผ่านการฝึกฝนจากโรงเรียนแพทย์โดยจำแนกวิธีการบำบัดในกลุ่มนี้ได้ 3 วิธี ได้แก่ การบำบัดโดยใช้ยา การบำบัดโดยใช้ไฟฟ้า (Electroconvulsive therapy, ECT) และการผ่าตัดเพื่อรักษาความผิดปกติทางจิต (psychosurgery) (Comer and Gould, 2013 pp.620-625)

4.2 จิตพลวัตบำบัด (Psychodynamic Therapy) เป็นจิตบำบัดรูปแบบหนึ่งที่ใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ และทฤษฎีจิตวิเคราะห์ยุคใหม่ เช่น ทฤษฎีวัตถุสัมพันธ์ (object relation theory) เป็นแนวคิดในการบำบัดผู้ป่วยทางจิต โดยมีเป้าหมายของการบำบัดเพื่อช่วยค้นหาเหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลทางใจในอดีต และความขัดแย้งภายในจิตใจที่เก็บกดในจิตใต้สำนึก ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ จากนั้นจึงจัดการกับความขัดแย้งนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตัวอย่างเทคนิคที่ผู้บำบัดใช้ เช่น การเชื่อมโยงอิสระ (Free Association) การแปลความหมายของผู้บำบัด (Therapist Interpretation) การระบาย (Catharsis) การแปลความฝัน (Dream Analysis) เป็นต้น (Comer and Gould, 2013 pp.625-627)

4.3 พฤติกรรมบำบัด (Behavioral Therapy) เป็นรูปแบบการบำบัดที่ประยุกต์จากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ได้แก่ การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ และการเป็นแบบอย่าง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตัวอย่างเทคนิคที่ผู้บำบัดใช้ ได้แก่

4.3.1 การเผชิญหน้า (Exposure) เป็นหนึ่งในเทคนิคทางพฤติกรรมบำบัดที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง เพื่อการบำบัดรักษาบุคคลที่มีความวิตกกังวลที่ผิดปกติ เช่น โรคลมชัก หรือโรคตื่นตระหนกโดยให้เผชิญกับสถานการณ์ วัตถุ หรือความทรงจำสิ่งที่ทำให้เกิดกังวล หรือหวาดกลัว ทั้งนี้ ผู้บำบัดอาจให้ผู้ป่วยใช้การจินตนาการถึงสถานการณ์ หรือให้ผู้ป่วยอยู่ในสถานการณ์จริง จนกว่าจะเกิดความคุ้นชิน ซึ่งเป็นผลให้ความกลัวหรือความกังวลนั้นจะลดลง

4.3.2 การลดความวิตกกังวลอย่างเป็นระบบ (Systematic desensitization) เป็นกระบวนการเพื่อลดความกลัวหรือความวิตกกังวลอย่างเป็นลำดับขั้น เริ่มต้นจากการให้ผู้รับการบำบัดจินตนาการหรือเผชิญกับสิ่งที่กลัวกังวลอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากนั้นที่สุดไปสู่ความกังวลมากที่สุด โดยแต่ละขั้นของการเผชิญสิ่งที่กลัว ผู้รับการบำบัดจะถูกฝึกการผ่อนคลายร่วมด้วย จนในที่สุดผู้รับการบำบัดสามารถเผชิญกับสิ่งที่กลัวกังวลได้ จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้

4.3.3 การกำกับการแสดงออกของตนเอง (Behavioral self-monitoring) เป็นวิธีการสำรวจและควบคุมตนเอง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจำเป็นต้องทราบตัวเสริมแรงที่ชักนำให้เกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์นั้นก่อน จากนั้นผู้บำบัดจะแนะนำผู้ป่วยให้บันทึกพฤติกรรมที่ตนเองต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อชี้ชัดถึงพฤติกรรมเป้าหมายว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน และกับใคร เมื่อสามารถระบุพฤติกรรมเป้าหมายและตัวเสริมแรงได้แล้ว ผู้บำบัดจะออกแบบโปรแกรมบำบัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

4.3.4 การฝึกฝนทักษะ (Skills training) สำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในทักษะทางสังคม เช่น เป็นคนขี้อายเมื่ออยู่ในสถานการณ์ทางสังคม การบอกว่า "ไม่ต้องอายหรอก" ไม่ใช่วิธีช่วยเหลือผู้ป่วยคนนี้ เพราะที่จริงแล้วผู้ป่วยไม่รู้วิธีการพูดคุยทักทายกับผู้อื่น ดังนั้นนักพฤติกรรมบำบัดจึงใช้หลักการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ การเป็นแบบอย่าง และการเล่นบทบาทสมมติ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาทักษะที่บกพร่องขึ้นมาได้ เช่น ผู้ป่วยที่บกพร่องทักษะทางสังคมและขี้อาย ผู้บำบัดจะช่วยให้เรียนรู้วิธีการสนทนาในสถานการณ์ทางสังคมโดยมุ่งความสนใจไปที่ผู้อื่นมากกว่าที่จะสนใจความไม่มั่นคงในจิตใจของตนเอง ดังนั้นเทคนิคการฝึกฝนทักษะจึงเป็นรูปแบบการบำบัดที่นักพฤติกรรมบำบัดออกแบบให้เหมาะสมกับปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ได้

4.3.5 การเป็นแบบอย่าง (Modeling technique) ผู้เสนอวิธีการนี้ คือ อัลเบิร์ต แบนดูรา โดยเห็นว่าผู้บำบัดต้องแสดงตนเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยได้เลียนแบบ เรียนรู้ และนำไปฝึกซ้อมจนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น ผู้บำบัดสาธิตวิธีการสบอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเร้าที่ทำให้กลัวหรือตื่นตระหนก โดยทั่วไปนักพฤติกรรมบำบัดจะใช้วิธีการเป็นแบบอย่างร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ ในการพัฒนาผู้ป่วย เช่น การพัฒนาทักษะทางสังคม การกล้าแสดงออก เป็นต้น

การใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมนิยมเป็นฐานความคิดในการบำบัดผู้ป่วย เป็นวิธีการที่มีงานวิจัยรองรับว่าใช้ได้ผลดีในผู้ป่วยโรคกลัว โรคย้ำคิดย้ำทำ ทักษะทางสังคมบกพร่อง บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมบำบัดเป็นวิธีที่ได้รับการวิจารณ์ว่าสนใจเพียงพฤติกรรมภายนอก ไม่สนใจว่าพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นผลจากกระบวนการทางจิตใจที่มีความซับซ้อน อีกทั้งผลจากการบำบัดยังไม่คงทน เป็นผลให้ในช่วงปี 1960-1970s นักพฤติกรรมบำบัดเริ่มสนใจพฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งมีผลต่อการแปลความและการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงผสมผสานแนวคิดทางพฤติกรรมและการรู้คิดเข้าด้วยกัน เรียกว่า พฤติกรรมบำบัดผ่านการรู้คิด (Wade and Tavris, 2009, pp. 413-415)

4.4 พฤติกรรมบำบัดผ่านการรู้คิด (Cognitive-Behavioral Therapy) ผู้บำบัดกลุ่มพฤติกรรมบำบัดผ่านการรู้คิดจะทำการบำบัดโดยยึดสมมติฐานที่ว่า ความคิดปกติทางความคิดเป็นศูนย์กลางของความผิดปกติทางจิต ดังนั้น ผู้บำบัดจะช่วยให้ผู้ป่วยตระหนักและเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดที่ไม่สมเหตุผลผลควบคู่กับการปรับพฤติกรรม เทคนิคการบำบัดในกลุ่มนี้จึงมีความหลากหลาย และนำเอาเทคนิคทางพฤติกรรมบำบัดมาใช้ร่วมด้วยเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ป่วยให้เหมาะสมมากขึ้น เช่น การบำบัดเชิงพฤติกรรม เหตุผล และอารมณ์ (Rational-Emotive Behavior Therapy) การบำบัดเชิงรู้คิด (Cognitive therapy) เป็นต้น (Comer and Gould, 2013 p.631)

4.5 การบำบัดตามแนวคิดมนุษยนิยมและเอกซิสเทนเชียล (Humanistic-Existential Therapy) ทั้งสองแนวคิดถูกจัดอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะมีจุดคล้ายคลึงกันในเรื่องมุมมองมนุษย์ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับแนวโน้มที่จะเติมเต็มศักยภาพและเติบโตไปในทางที่ดีงาม อย่างไรก็ตามคนเราจะสามารถทำเช่นนั้นได้ หากสามารถประเมินตนเองอย่างตรงไปตรงมาและยอมรับทั้งข้อดีและข้อด้อย รวมทั้งค้นหาคุณค่าในการดำรงตน ซึ่งแนวคิดกลุ่มนี้มองว่าความผิดปกติทางจิตเกิดจากนิสัยหลอกตนเอง และมีมุมมองที่บิดเบือนจากความจริง ดังนั้นนักบำบัดตามแนวคิดมนุษยนิยมและเอกซิสเทนเชียล จึงไม่มุ่งเน้นการบำบัดไปยัง

ความขัดแย้งหรือสาเหตุในอดีต แต่มุ่งเน้นที่ตัวตนในปัจจุบันของผู้ป่วย ตัวอย่างการบำบัดในกลุ่มนี้ คือ การบำบัดแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy) การบำบัดแนวเกสตัลท์ (Gestalt Therapy) การบำบัดแนวเอกซิสเทนเชียล (Existential Therapy) สำหรับแนวคิดกลุ่มนี้มีจุดแข็งคือการมีมุมมองต่อมนุษย์ในด้านบวก การช่วยให้ผู้ป่วยตระหนักถึงคุณค่าและเป้าหมายในชีวิต (Comer and Gould, 2013, pp.635-637; Gerrig and Zimbardo, 2008, pp. 502-504)

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4

จับคู่การบำบัด กับแนวคิดเกี่ยวกับการบำบัดที่เหมาะสม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ก. การบำบัดแนวจิตพลวัต | ข. การบำบัดตามแนวคิดมนุษยนิยม |
| ค. พฤติกรรมบำบัดผ่านการรู้คิด | ง. พฤติกรรมบำบัด |
| จ. วิธีรักษาทางสมอง | |

-1. การบำบัดที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาในระดับจิตใต้สำนึก
-2. การบำบัดที่เชื่อว่าความผิดปกติทางจิตมีสาเหตุจากความคิดที่บิดเบือน
-3. การบำบัดที่ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ และแบบคลาสสิกมาใช้
-4. การบำบัดที่เชื่อว่าความผิดปกติเกิดจากการทำหน้าที่ผิดปกติของระบบสารสื่อประสาท
-5. การบำบัดที่มีมุมมองว่ามนุษย์มีศักยภาพและสามารถเติบโตในทางที่ดีงามได้

5. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

แนวทางการป้องกันความผิดปกติทางจิต

การมีบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต หรือผู้ป่วยทางจิตเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการพัฒนาประเทศ และถือเป็นวิกฤตของระบบสาธารณสุข เนื่องจากการบำบัดรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตต้องใช้เวลา นาน อาจรักษาไม่หายขาด และต้องบำบัดรักษาไปตลอดชีวิต ดัชนีเสียงทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแล อีกทั้งต้องสูญเสียทรัพยากรในการพัฒนาประเทศชาติมากมาย ดังนั้นการป้องกันตั้งแต่ยังไม่ป่วย จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาทรัพยากรของประเทศ และมีความคุ้มค่ามากกว่าการบำบัดรักษาเมื่อป่วยแล้ว

แนวทางการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิตทางตรง และได้ผลอย่างรวดเร็ว จะต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกันในประเด็นต่อไปนี้

5.1 คุณลักษณะร่างกายให้แข็งแรงตั้งแต่ช่วงก่อนมีอาการป่วย หรือเพิ่งเริ่มป่วยทางจิต จะช่วยลดความรุนแรงและอาการแทรกซ้อนของโรค งานวิจัยที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าผู้ป่วยโรคจิตเภท จะมีอายุเฉลี่ยลดลง 20 ปี และมีโรคทางกายอื่น ๆ แทรกซ้อน ดังนั้นการส่งเสริมดูแลด้านสุขภาพกายตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ช่วยลดความเจ็บป่วยทางกายลงได้ดีพอ ๆ กับการเจ็บป่วยทางจิตใจ นอกจากนี้บุคคลที่ไม่มีความเจ็บป่วยทางจิตซึ่งมีการดูแลสุขภาพร่างกายดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอจะลดโอกาสเจ็บป่วยทางร่างกายไปพร้อมกับความเจ็บป่วยทางจิตได้เช่นเดียวกัน

5.2 การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือการติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น เนื่องจากการแยกตัวจากสังคมเป็นลักษณะเด่นชัดของความผิดปกติ และเป็นหนึ่งในความทุกข์ทรมานจากโรคทางจิตเวช รวมทั้งเป็นสาเหตุและความเสี่ยงทางสังคมต่อความเจ็บป่วยทางจิต ดังนั้นการป้องกันการแยกตัวจากสังคมโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนทางบวกที่ลดโอกาสเจ็บป่วยทางจิตแบบเรื้อรังได้

5.3 การสร้างความตระหนักในศักยภาพของตนเอง เนื่องจากบุคคลที่เสี่ยงต่อการป่วยทางจิตมักไม่เผชิญปัญหาหรือความต้องการต่าง ๆ ในชีวิต จึงเป็นอุปสรรคขวางกั้นตนเองจากการไปสู่เป้าหมายชีวิต ส่งผลให้เกิดความบกพร่องต่อการวางแผนชีวิต รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การเรียน การประกอบอาชีพ และการคงความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว ดังนั้นการที่บุคคลพยายามแก้ไขปัญหาและเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต เพื่อค้นหาความหมาย และศักยภาพในชีวิตตนเอง จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ช่วยลดความเจ็บป่วยทางจิตได้

5.4 การบรรลุความต้องการพื้นฐาน เพราะมนุษย์มีความต้องการพื้นฐานหลายด้าน เช่น ความต้องการทางสรีระ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรักและการยอมรับ สำหรับบุคคลที่ดำเนินชีวิตโดยสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตได้ ย่อมลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิต เช่น การทำหน้าที่ด้านการเรียน การทำงาน การปกป้องตนเองจากอันตราย การใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลในสังคมโดยยอมรับกฎเกณฑ์ในสังคม เป็นต้น (DeVylder, 2015)

สิ่งสำคัญอีกประการสำหรับผู้เรียนรู้เรื่องความผิดปกติทางจิต คือ การปรับเจตคติของตนเองที่มีต่อผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ปอยครั้งที่ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้นำเสนอภาพของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตในแง่ของการตีตรา ความเลวร้าย โดยมีได้ตระหนักถึงผลที่ตามมา จึงชักนำให้สังคมเกิดเจตคติทางลบต่อผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ดังนั้นเมื่อผู้เรียนเข้าใจที่มาของความผิดปกติทางจิตและการบำบัดแล้ว

ย่อมเข้าใจว่าผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตคือผู้ป่วย และเป็นบุคคลที่มีความทุกข์ทรมานจากอาการของโรค จึงควรให้ความเห็นอกเห็นใจและให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ในฐานะผู้ป่วย มิใช่คนแล้ว ไม่ควรหลีกหนี หรือกีดกันบุคคลเหล่านี้ออกจากสังคม

สรุป

1. การนิยามความผิดปกติทางจิตมีความซับซ้อน แต่มีหลักสำคัญ ดังนี้ (1) การมีความคิดและอารมณ์ที่ไม่เป็นสุขเป็นเวลานาน (2) การทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันบกพร่อง (3) มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานทางสังคม และ (4) มีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง

2. สาเหตุของความผิดปกติทางจิต ประกอบด้วย ได้แก่ ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยทางสังคม

3. ความผิดปกติทางจิตที่ควรรู้จัก ได้แก่ (1) โรคจิตเภท (2) โรควิตกกังวล (3) โรคย้ำคิดย้ำทำ (4) โรคซึมเศร้า (5) โรคอารมณ์สองขั้ว (6) บุคลิกภาพที่ผิดปกติ (7) ความผิดปกติทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ และ (8) ความผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยอันตรายและความเครียด

4. โรคจิตเภท คือ โรคจิตที่ประกอบด้วยอาการดังนี้ (1) การหลงผิด (2) ประสาทหลอน (3) มีอาการสับสนและพูดจาไม่ต่อเนื่องและ (4) พฤติกรรมแปลกประหลาดไม่เหมาะสม และ (5) มีความบกพร่องทางการรู้คิด

5. โรควิตกกังวล คือ ความกลัวหรือความวิตกกังวลที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งเร้าที่เผชิญ ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน แม้ว่าสถานการณ์หรือความเป็นอันตรายนั้นจะผ่านพ้นไปแล้ว ความผิดปกติในกลุ่มนี้ คือ (1) โรควิตกกังวล (2) โรคตื่นตระหนก (3) โรคกลัว (4) โรควิตกกังวลทางสังคม

6. โรคย้ำคิดย้ำทำ คือ ลักษณะของความคิดและพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นเป็นแบบแผนซ้ำไปซ้ำมา โดยที่ผู้ป่วยไม่ปรารถนา และรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย

7. โรคซึมเศร้า คือ ความผิดปกติทางอารมณ์ระดับรุนแรงที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรม การรู้คิด และร่างกาย ซึ่งรบกวนการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวัน โดยอาการแสดงของผู้ที่เป็นโรคจะรู้สึกเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่สนใจและรู้สึกไม่พึงพอใจต่อกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการคิดถึงเรื่องความตายและการฆ่าตัวตาย

8. โรคอารมณ์สองขั้ว เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งมีการแสดงอารมณ์สองขั้ว ได้แก่ ขั้วของอารมณ์ซึมเศร้า สลับกับขั้วของอารมณ์คลุ้มคลั่งหรือมีอาการเรื้อรังเกินปกติ

9. โรคบุคลิกภาพที่ผิดปกติ คือ ลักษณะนิสัยและรูปแบบการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมเปลี่ยนแปลงได้ยาก เป็นสาเหตุของความทุกข์ใจและทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถสร้างความผูกพันกับผู้อื่นได้ ความผิดปกติในกลุ่มนี้ เช่น (1) บุคลิกภาพผิดปกติแบบพึงพิง (2) บุคลิกภาพ

ผิดปกติแบบหลงตัวเอง (3) บุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (4) บุคลิกภาพผิดปกติแบบแยกตัว และ (5) บุคลิกภาพผิดปกติแบบถ้อยหน้า เป็นต้น

10. ความผิดปกติทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ คือ กลุ่มอาการของความผิดปกติทางจิตซึ่งแสดงออกในลักษณะของอาการทางร่างกาย ความผิดปกติในกลุ่มนี้ คือ (1) โรคความผิดปกติเกี่ยวกับอาการทางกาย (2) โรควิตกกังวลต่อความเจ็บป่วย (3) โรคคอนเวอร์ชัน

11. ความผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยอันตรายและความเครียด ความผิดปกติชนิดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับภัยอันตรายหรือความเครียดที่เกินกว่าความสามารถในการปรับตัว ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานติดอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตของตนเอง

12. การบำบัดหรือการรักษา คือ กระบวนการต่างๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดปกติให้กลับสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกัน ได้แก่ วิธีรักษาทางสมอง จิตพลวัตบำบัด พฤติกรรมบำบัด พฤติกรรมบำบัดผ่านการรู้คิด และการบำบัดตามแนวคิดมนุษยนิยมและเอกซิสเทนเชียล

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. นานหลายปีแล้ว ที่สมปองมีอาการหงุดหงิด กระสับกระส่าย และวิตกกังวล เวลาที่ต้องเดินผ่านสถานที่ ๆ สมปองเคยถูกวิ่งราวกระบี่กระบอง ลักษณะเช่นนี้สมปองอาจมีความผิดปกติทางจิตแบบใด

ก. โรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง	ข. โรควิตกกังวล
ค. โรคย้ำคิดย้ำทำ	ง. โรคกลัว
จ. โรคตื่นตระหนก	
2. ทุกครั้งที่ แม่กอดน้องชายแรกคลอด เด็กชายอรรถพลจะรู้สึกเจ็บปวด และลงไปตื่นร้องไห้กับพื้น เด็กชายอรรถพลอาจมีความผิดปกติแบบใด

ก. โรคความผิดปกติทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ	ข. โรคคอนเวอร์ชัน
ค. โรควิตกกังวล	ง. โรคจิตเภท
จ. โรคซึมเศร้า	
3. ข้อใด ไม่ใช่อาการของโรคจิตเภท

ก. เจนนี่มองเห็นวิญญาณพ่อที่เสียชีวิตไปอยู่กับเธอตลอดเวลา	ข. หลัวเชื่อว่าสามีคงอยู่ไม่ได้ถ้าขาดตนเอง จึงต้องอยู่ข้าง ๆ สามีตลอดเวลา
ค. ชัชพลรู้สึกว่ามีแมลงไต่อยู่ใต้ผิวหนัง แม้ว่าไปตรวจแล้วจะไม่พบอะไร	ง. มณีเชื่อว่าตนเองถูกเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามาชมขี้นคนทุกคืน
จ. เบ็นซ์เชื่อว่าใครของตนเองถูกขโมยไป	
4. นายธนพล เข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา สูดบุหรี่ในมหาวิทยาลัย ไม่ปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัย ชอบแข่งแถวผู้อื่นไปซื้อข้าว และเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเอาเปรียบผู้อื่นได้ เพราะใคร ๆ ก็ทำกัน เช่นนี้แล้ว นายธนพลน่าจะมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติแบบใด

ก. แบบหลงตัวเอง	ข. แบบต่อต้านสังคม	ค. แบบแยกตัว
ง. แบบคาบเส้น	จ. แบบแปลกแยก	
5. นางสาววินากลัวความสูง แต่จำเป็นต้องทำงานในตึกสูงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ท่านคิดว่าควรให้ นางสาววินารับการบำบัดแบบใด

ก. จิตพลวัตบำบัด	ข. ยาคลายกังวล	ค. พฤติกรรมบำบัด
ง. การบำบัดแนวมนุษยนิยม	จ. ใช้วิธีบำบัดแบบใดก็ได้	
6. การแปลความฝันจัดเป็นเทคนิคการบำบัดทางจิตโดยใช้ฐานทฤษฎีใด

ก. มนุษยนิยม	ข. พฤติกรรมนิยม	ค. เอกซิสเทนเชียล
ง. การบำบัดสมอง	จ. จิตพลวัต	

7. การบำบัดแนวเกสตัต์ เป็นการบำบัดในกลุ่มแนวคิดใด
- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| ก. มนุษยนิยม | ข. พฤติกรรมนิยม | ค. เอกซิสเทนเชียล |
| ง. การบำบัดสมอง | จ. จิตพลวัต | |
8. ท่านสามารถรับการบำบัดทางจิต ได้จากผู้ใดบ้าง
- | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|
| ก. พยาบาลจิตเวช | ข. นักสังคมสงเคราะห์ | ค. นักจิตวิทยา |
| ง. จิตแพทย์ | จ. ถูกทุกข้อ | |
9. ข้อใด ไม่ใช่ การบำบัดผู้มีความผิดปกติทางจิต
- | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| ก. การใช้ไฟฟ้า | ข. การออกกำลังกาย | ค. การผ่าตัด |
| ง. การเพ่งสมาธิ | จ. ถูกต้องทั้งข้อ ข. และ ง. | |
10. ข้อใดคือสาเหตุของความผิดปกติทางจิต
- | |
|-----------------------------------|
| ก. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์นานเกินไป |
| ข. การนอนหลับน้อยกว่า 6 ชั่วโมง |
| ค. การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ |
| ง. พันธุกรรม |
| จ. ถูกทั้งข้อ ค. และ ง. |

บรรณานุกรม

- กรมสุขภาพจิต. (2547). ร่างทรงสติแตก-สั่งเชือดลูก!..โรคจิตทางทฤษฎี. ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2558, จาก http://www.dmh.go.th/Sty_Lib/articles/view.asp?id=858
- กระปุกดอทคอม. (2551). พบพ่อโรคจิต ฆ่าลูกสาว 10 ปี. ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2558, จาก <http://highlight.kapook.com/view/24426>
- รัตนา สายพานิชย์ และธนิศา หิรัญเทพ. (2558). โรคจิตกักขัง. ในมานุษย หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์ (บรรณาธิการ). จิตเวชศาสตร์วามาศิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลวามาศิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- Coon, D. and Mitterer, J. O. (2012). Introduction to Psychology: active learning through modules (twelfth edition). Victorin: Wadsworth/Cengage Learning.
- Coon, D. and Mitterer, J. O. (2016). Introduction to Psychology: Gateways to mind and behavior (Fourteenth edition). Boston, MA: Cengage Learning.
- Comer, R. and Gould, E. (2013). Psychology around us (2nd ed.). NJ: John Wiley & Sons.
- DeVylder, J. E. (2015). Prevention of Schizophrenia and severe mental health illness (Grand Challenges for Social Work Initiative Working Paper-No.6). Cleveland, OH: American academy of Social Work & Social Welfare.
- Freeman, A., Felgulse, S. H. and Davis, D. D. (2008). Clinical psychology: integrating science and practice. NJ: John Wiley & Sons.
- Gerrig, R. J. and Zimbardo, P. G. (2008). Psychology and life (8th ed.). Boston: Pearson.
- Kalat, J. W. (2017). Introduction to Psychology (11th ed.). MA: Cengage Learning.
- Myers, D. G. (2009). Psychology in everyday life. NY: Worth Publishers.
- Wade, C. and Tavis, C. (2009). Invitation to psychology (4th ed.). NJ: Pearson.
- Weiten, W. (2007). Psychology: themes & variations (7th ed.). CA: Thomson Learning.
- Zide, M. R. & Gray, S. W. (2001). Psychopathology: A competency-based assessment model for social workers. CA: Brooks/Cole Thomson learning.